

Pr Benlkhiate 2

C'est une patiente de 40 ans ayant réservé à l'institution cardinale de l'Ouest de récréation, position gastro-territoriale, des sténoses gastriques, une infusion intestinale très bien, mademoiselle Alexandre, parfois aussi intestinale libre. Causes les plus fréquentes au niveau migrable sont les brides et les odorants. C'est le cas ici, c'est une patiente qui a déjà eu, on va l'appeler une agression chirurgicale de son abdomen, de son périodoine.

Donc ça va expliquer ce tableau d'occlusion intestinale. Gastro-enterite c'est pas le tableau, normalement c'est un syndrome péripale, c'est des diarrhées, c'est pas l'arrêt des matières et des gaz. Sténose gastrique pylorique c'est faux, puisqu'il faut contextualiser, c'est un patient avec un certain profil tabagique qui est connu ulcéreux, qui est connu porteur d'un ulcère, et qui se complique de sténose pylorique, donc des vomissements post-chromio tardifs, avec un clapotage à jeun à l'examen clinique, donc c'est pas le cas.

Occlusion c'est la proposition qui est juste et vraie. C'est les étiologies les plus fréquemment rencontrées, ce sont les brides et les adhérences. Je vous rappelle que l'étiologie des brides et des adhérences n'est pas encore bien élucidée jusqu'à aujourd'hui.

On ne comprend pas pourquoi les patients ont des brides et des adhérences après une intervention chirurgicale antérieure. L'appendicite mésocélique c'est pas le tableau clinique, puisque l'apport mésocélique, on l'a vu dans le cours des appendicites, que les appendicites, la première particularité, c'est la variation des tableaux cliniques. C'est la variation des tableaux cliniques, et donc on peut avoir des signes cliniques en fonction de la localisation de l'appendice.

Dans la forme mésocélique, ça veut dire que l'appendice, elle se balade entre les ondes intestinales, et elle danse ce qu'on appelle un tableau d'occlusion fonctionnel, qui va accompagner le tableau d'appendicite aiguë, c'est pas le cas ici, puisque normalement, la douleur s'accompagne d'un tableau de fièvre, c'est une occlusion fébrile, l'appendicite mésocélique, c'est pas le cas ici. Enfin, l'infarctus mésentérique veineux, normalement, l'occlusion survient chez un patient ayant des antécédents cardiaques, ce sont des malades qui sont suivis chez le cardiologue pour des problèmes ayant lieu sous médicaments, sous anticoagulants, c'est pas le cas ici. On passe à la deuxième question.

Pour confirmer votre diagnostic, vous demandez une fibroscopie d'une visible haute, un transit oesogastro-dodécal, un scanner abdominal, une échographie abdominale, proposition E, une coloscopie. Donc vous avez cinq propositions. La première proposition, c'est la fibro.

Bravo mademoiselle Ferdows-Mahssine, elle a répondu à la proposition C. Donc, normalement, pour confirmer notre diagnostic d'occlusion, on a besoin d'une TDM abdominale. La fibroscopie digestive haute, normalement, c'est pour diagnostiquer l'astérosis d'asthme thyroïde, mais c'est pas le diagnostic à évoquer. Le TOGD, c'est un examen complémentaire un peu dépassé,

bonjour, puisqu'on le demande de moins en moins.

Le scanner, il reste incontournable, et maintenant, toutes les structures, ici à Marrakech, tous les hôpitaux, on trouve la TDM abdominale, donc n'hésitez pas à demander un scanner devant le soupaveau clinique chez tel patient ayant des antécédents, pour confirmer le diagnostic d'occlusion intestinale aiguë sur bride. Donc, Mlle Menel aussi a répondu juste. L'échographie ne va pas faire avancer grand-chose, puisque c'est des patients qui ont une occlusion, donc il y a beaucoup de gaz, ils sont ballonnés, et on sait que l'échographie est très limitée, très gênée par la distension gazeuse des ondes intestinales, et du volant.

La coloscopie, je peux même dire qu'elle est contre-indiquée, dans ce cas-là. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, pour réviser tous les chapitres, si vous voulez. Si vous avez des questions, on va répondre.

Troisième question, ça concerne le kystidatique. Alors, le kystidatique du dents, premièrement, on ne commence pas par l'ASP. Si jamais la structure dans laquelle vous allez travailler, soit que vous êtes dans une clinique ou dans un hôpital, ne comprend pas la TDEM, oui, l'ASP va nous rendre service, mais si jamais la TDEM est disponible, je pense qu'il faut commencer, d'autant plus que l'ASP ne figure pas dans les propositions, dans ces propositions de cette question-là, donc je pense qu'il faut commencer par la TDEM.

Et en plus, l'ASP est un examen complémentaire qui ne rend pas assez de service, si on le compare par rapport à la TDEM. La TDEM, c'est une mine d'informations. Elle renseigne sur l'état des ongles intestinaux, sur la présence ou non de pneumo-péritoine.

Il y a certains de vous qui vont dire qu'on peut retrouver le pneumo-péritoine sur l'ASP, mais pas toujours. Parfois, l'ASP, on le cherche minutieusement au scanner, mais parfois, on ne l'observe pas sur l'ASP. Et donc, l'ASP, la TDEM, en matière d'occlusion, elle va nous renseigner même sur la nature et l'étiologie de l'occlusion.

Elle peut voir une tumeur, elle peut voir son évolution, son contact et ses rapports avec les organes de voisinage. On peut voir exactement le siège de l'occlusion, chose que l'ASP ne peut pas nous répondre et nous avancer sur tout cela. Je reprends la troisième question, le kystidatique du dôme hépatique.

Première proposition, il est très rare au Maroc. Deuxième proposition, il se présente sous forme d'un kyst unique au niveau du foie, toujours sous forme d'un kyst unique. Troisième proposition, il se complique fréquemment d'une fistule bilio-branchique.

Quatrième proposition, il intéresse les segments 4 et 5. Ils se prêtent au traitement stéréoscopique par excellence. J'ai trois réponses. Mlle Menel a répondu à la proposition C, c'est-à-dire qu'il se complique fréquemment d'une fistule bilio-branchique, donc c'est vrai.

Harjar aussi a répondu juste. M. Weber aussi, Mlle Safa aussi. Je reprends les propositions.

Donc il est très rare, au contraire, il est endémique au Maroc. On a dit que c'est un problème de santé publique. Il pose beaucoup de problèmes.

Et l'éradication du kystidatisme passe par la prévention. Et la prévention, je suppose, le travail des médecins, le travail des médias, le travail de la société, donc c'est la législation des abattoirs pour remplir et faire arrêter, faire stopper le cercle de cette maladie. On a vu dans le cours que c'est une maladie parasitaire due à un verbe qui vit normalement dans l'intestin grêle des chiens.

Et donc le traitement et la légalisation, la prise en charge par les vétérinaires des chiens pourra faire stopper cette maladie. On a dit également que la légalisation des abattoirs, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, il y a des viandes qui sont préparées dans les souks de la périphérie de Marrakech. Et donc c'est ce qui explique que cette maladie va encore sévir malheureusement dans notre pays.

Donc il est très endémique au Maroc. Il se présente toujours sous forme d'un kyst unique au niveau du poid. Le kyst hydatique peut être multiple au niveau du poid.

On peut avoir deux kysts, trois kysts, voire même ce qu'on appelle une hydatidose hépatique. Donc il peut s'agir de beaucoup de kysts, de plusieurs kysts. Il se complique fréquemment d'une fistule.

C'est la proposition qui est juste. Donc la proposition C. Le dôme hépatique, c'est le segment 7 et 8. C'est la partie supérieure du foie. Donc lorsque le kyst hydatique va grossir et grandir, il va prendre du volume.

Et jour après jour, il va comprimer le diaphragme. Ce dernier va finir par se nécroser. Ajoutez à ceci la pression négative qui sévit dans le thorax, dans les poumons.

Ajoutez à ceci le rôle corrosif de la bile qui va grignoter le diaphragme. Et donc le kyst va finir par se fistuliser et le patient va présenter ce qu'on appelle une bilipisie. C'est-à-dire qu'il va, à l'occasion d'une crise de toux, cracher de la bile.

Et cette bilipisie est un signe sémiologique qui est spécifique, pathognomonique du kyst hydatique fistulisé. Donc c'est un kyst hydatique du dôme hépatique, des segments 7 et 8, fistulisés dans les poumons. Il intéresse surtout les segments 4 et 5. C'est faux.

Les segments 4 et 5 sont antérieurs. Je vous invite à revoir l'anatomie de la segmentation hépatique. Donc j'ai une question ici.

Pouvez-vous nous rappeler le dôme hépatique? Donc c'est les segments 7 et 8. C'est des segments postérieurs et supérieurs du foie. Donc brièvement, la segmentation hépatique est la base, sa connaissance est très importante. C'est la base pour prendre en charge ce genre de

malade.

Dans l'avenir, vous ne pouvez pas traiter un malade qui a un kyst hydatique sans savoir la segmentation hépatique. La segmentation hépatique a démarré dans les années 40, 1940, 1950, avec les travaux d'un chirurgien vietnamien qui a, si vous voulez, qui a brisé le mythe de la chirurgie hépatique. Avant ces années 40 et avant ce chirurgien vietnamien, le chirurgien n'osait pas toucher et opérer le foie parce que la chirurgie hépatique, elle saigne abondamment et elle s'accompagne d'hémorragies hyperopératoires.

Donc c'est grâce à ce chirurgien qui s'appelait Tung Ta Tung, il a compris que les vaisseaux, les vaisseaux du foie, c'est-à-dire je parle du pédicule hépatique, le pédicule sous-hépatique, quand il veut pénétrer le parenchyme hépatique, il pénètre, vous avez la veine porte qui pénètre accompagnée de l'artère et du canal biliaire. Ces trois éléments, ils cheminent dans le parenchyme hépatique accompagnés tous les trois et entourés, enveloppés d'une émanation, d'une prolongation de la capsule de glissants. Donc cette division, la division de l'un de ces éléments, ça suppose la division de l'artère hépatique et la division des canaux hépatiques.

Donc si vous voulez, la veine porte, une fois au niveau du fil hépatique, elle va se diviser en branches portales droite et en branches portales gauche et déjà cette division va délimiter deux territoires, le foie droit et le foie gauche. Et ceci n'a rien à voir avec l'anatomie classique qui va parler du lobe droit et du lobe gauche. Donc là, la segmentation hépatique, lorsque la veine porte va se diviser en deux branches, elle va donner le foie droit et le foie gauche.

La branche droite de la veine porte va continuer le trajet du trempote et elle va se diviser en deux branches segmentaires. Le segment paramédion de deux secteurs, un secteur paramédion et un secteur latéral. Le secteur paramédion va donner deux segments.

Un segment antérieur qui est le segment 5 et un segment postérieur et supérieur, c'est le segment 8. La branche latérale va donner deux segments. Un segment antérieur qui est le segment 6 et un segment postérieur, c'est le segment 7. Donc la branche portale droite va nous donner quatre segments finalement. Les segments 5, 6 antérieurs, 7 et 8 qui sont postérieurs et on les appelle les dents hépatiques parce qu'ils sont au contact du diaphragme.

Et donc la localisation du cystidatique à leur niveau va exposer les patients à présenter cette complication qui est la fistule biliobronchique. Et donc la proposition D, elle est fausse, les segments 4 et 5 sont antérieurs. La proposition E se prête au traitement stélioscopique.

C'est très difficile de traiter un cystidatique du dents hépatique par stélio. C'est même dangereux. On va exposer le malade à la dissimulation du liquide du cyste qui est très riche en scolex et ça risque de diffuser et d'entraîner en post-opératoire ce qu'on appelle une idatidose péritoniale.

Donc ça va transformer le pronostic en quelque sorte. Donc si vous n'avez plus de questions sur le cystidatique, on passe à d'autres questions. L'adénocarcinome du colon, un des cancers

digestifs les plus fréquents.

Première proposition, il est rare au Maroc. Deuxième proposition, l'hérédité n'est pas un facteur favorisant. Troisième proposition, le diagnostic est assez souvent porté au stade de complications à type d'occlusion.

Proposition D, ne peut compliquer un polype négligé. E, le traitement est surtout basé sur la radiothérapie. Donc mademoiselle Hajar a répondu C, mademoiselle Khadija Mansour a répondu C, Marwa C, Manel, Firdaus, AC.

Il est rare au Maroc. Donc c'est faux, mademoiselle Firdaus. Au contraire, l'adénocarcinome du colon est endémique au Maroc et on l'a déjà traité au cours.

Si vous révisez le cours, vous allez voir que le cancer du colon est endémique, c'est un problème de santé publique. Donc il est très fréquent au Maroc. C'est le premier cancer digestif de point de vue fréquence au Maroc.

Donc la proposition A, c'est faux. B, l'hérédité n'est pas un facteur favorisant. Au contraire, l'hérédité joue un rôle très important.

Il y a même des familles qui ont ce problème. Donc il faut toujours, à l'interrogatoire, chercher cette notion d'hérédité. Chaque fois que vous allez prendre en charge un patient qui a un cancer du colon, il faut l'interroger sur les antécédents familiaux, surtout le père, les cousins, les frères, s'il y a quelqu'un qui est suivi.

Parce que rien qu'à l'interrogatoire, à ce stade-là, vous pouvez faire venir toute la famille pour une coloscopie si jamais on diagnostique cette maladie familiale. Et donc il faut proposer la coloscopie pour diagnostiquer le cancer à un stade précoce. Ça s'appelle la prévention secondaire.

On peut pratiquer la prévention secondaire en demandant des coloscopies lorsqu'on diagnostique la notion de cancer familial, surtout concernant la dénocarcinome du colon. Donc la proposition C, le diagnostic est assez souvent porté au stade de complication à type d'occlusion. Malheureusement, c'est vrai, c'est juste.

Malheureusement, j'espère que dans l'avenir, avec le nombre de médecins, on va commencer à faire des diagnostics à un stade assez précoce. Est-ce qu'un patient au stade de métastase est considéré toujours comme ayant un mauvais pronostic? Il faut savoir qu'actuellement, la prise en charge des cancers, des métastases, surtout hépatiques, donc je vais parler surtout des métastases hépatiques, n'est pas un facteur de mauvais pronostic. Parce qu'actuellement, on peut même guérir un patient qui a des métastases hépatiques.

Donc la localisation hépatique des métastases, c'est la localisation la plus fréquemment rencontrée, c'est la plus fréquente. Et on peut, bien sûr, à condition que la prise en charge soit

correcte. Je vous rappelle que la prise en charge de tels malades qui ont des métastases et des cancers du colon doit être multidisciplinaire.

Donc on doit les faire passer dans le staff multidisciplinaire d'oncologie, notamment pour leur proposer la meilleure attitude thérapeutique possible. Donc la prise en charge d'un patient ayant des métastases, surtout hépatiques, n'est pas considérée comme mauvais pronostic. Et le cancer du colon, c'est l'un des cancers où on a les meilleurs résultats, c'est-à-dire la meilleure espérance de vie.

Grâce à la chimiothérapie, grâce à la chirurgie, on peut guérir un cancer du colon. Je reviens aux propositions. Ne peut se compliquer, ne peut compliquer un polype.

Au contraire, les polypes, c'est des facteurs favorisants. Il faut savoir les chercher avant la cancérisation. Il faut les chercher pour les traiter.

Si on a affaire à un polype solitaire, on peut même le proposer à un gastro-entérologue pour une résection à l'ence diathermique, et on va étudier sa base d'implantation à l'anapath pour voir est-ce qu'il n'aura pas besoin d'un complément. Si jamais il n'y a pas de cancer sous-jacent, on peut guérir le polype et ne pas arriver au stade de cancérisation. Le traitement est surtout basé sur la radiothérapie.

La radiothérapie, non, ce n'est pas vrai. La radiothérapie, c'est pour le cancer du rectum. La radiothérapie, peut-être qu'il y a quelques indications, mais le cancer du colon est surtout chirurgical.

Il faut toujours privilégier la chirurgie pour régler le problème du cancer du colon. Donc, j'attends toujours des questions pour pouvoir discuter. J'attends toujours les questions.

Un cancer. Donc, cinquième question. Les avantages du traitement de la lithiase vésiculaire par CLIO par rapport à la chirurgie conventionnelle.

Donc, si vous voulez, on va comparer la polycystectomie CLIO à la polycystectomie parfois sous-costale. La CLIO est contre-indiquée en cas de polycystite aiguë. Proposition A. Proposition B. La durée d'hospitalisation est plus longue.

Proposition C. La reprise de l'activité professionnelle par le patient est tardive. Proposition D. La consommation des antalgiques en post-opératoire est plus importante. Ce qui implique rarement d'occlusion par bride.

Donc, j'ai une seule question, une seule réponse par mademoiselle Hajar. Elle a répondu E. Mademoiselle Belima aussi E. Donc, finalement, la réponse juste, c'est le E. La celluloscopie, c'est une voie d'abord. C'est le code standard pour traiter une lithiase de la visibilité actuellement.

La celluloscopie est contre-indiquée en cas de polycystite. On peut opérer les polycystites par

celluloscopie avec tous les avantages de la celluloscopie. Donc, surtout chez des malades qui sont barrés, un malade diabétique, un malade insuffisant respiratoire, un malade qui présente une polycystite gangrénée, la cellulose.

Parmi les avantages, c'est qu'elle évite la supérotation des plaies et des abcès de la paroi. Donc, la proposition A, c'est faux. La proposition B, la durée d'hospitalisation est plus lente.

Au contraire, avec une polycystectomie cellulaire, le patient peut quitter l'hôpital le lendemain et quitter la clinique. Ou même, la polycystite cellulaire peut se traiter à la chirurgie dite « ambulatoire ». C'est-à-dire que si on programme le malade à une telle chirurgie, on peut l'hospitaliser le matin et le faire sortir le soir. C'est ce qu'on appelle la chirurgie « ambulatoire ». Donc, avec les avantages de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qu'on va diminuer le coût de la prise en charge de ces malades.

Si le malade rentre chez lui, on va diminuer la durée d'hospitalisation. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans cette prise en charge lors de la chirurgie ambulatoire. Donc, la durée d'hospitalisation est plus lente, c'est une proposition qui est fausse.

La reprise de l'activité professionnelle par le patient est perdue. D'ailleurs, je vous ai raconté l'histoire de la première colicistectomie qui a été faite par un chirurgien à Lyon, dans la ville de Lyon, de Philippe Mouret. Philippe Mouret a opéré, en 1987, une lame qui fut cuivée dans son pelvis.

Il l'a opérée pour une cellulose exploratrice de son pelvis. Et donc, la patiente avait une lithiase musculaire, elle avait une necrophilia. Et lui, il voulait faire juste la cellulose.

Et en explorant le pelvis, en introduisant l'opisque par l'embrylique et en regardant le pelvis, ça se faisait dans le but de la stérilité ou je ne sais pas la raison pour laquelle il a fait cette lame. Il s'est dit pourquoi faire la lithiase de la visicule biliaire par cette technique-là, par la laparoscopie. Et il a commencé à opérer et il a trop aimé.

Il a tardé puisque les instruments et le matériel n'étaient pas adaptés. Et le lendemain, lorsqu'il a fait la visite et il a remarqué que sa patiente était sur le canapé, elle s'est déjà mise debout. Donc, il a remarqué que c'est à ce moment-là qu'il avait avancé dans la vidéosurgie et dans la celluloscopie.

Et c'est là qu'il a réalisé, qu'il a percé dans la chirurgie cellulose. Et donc, il a présenté son observation. Il a présenté cette lame dans un congrès à Los Angeles.

Et les Américains se sont vite précipités pour améliorer le matériel de la cellulose, les pinces, les moniteurs, les télévisions, pour voir le matériel. Puisqu'au début, le chirurgien avait l'œil rivé sur l'opisque. Donc, il n'y avait que le chirurgien qui voyait ce qui se passait à l'intérieur de l'abdomen.

Et maintenant, comme vous allez voir dans les services lors de vos stages, vous allez voir que toute la salle, toute l'assistance peut observer le geste que pratique le chirurgien grâce au moniteur, voire même grâce à la présence de deux moniteurs. Dans le service, on a deux moniteurs, deux écrans pour les colonnes de cellulose. Proposition D, la consommation des antalgiques en post-opératoire est plus importante.

Donc, la consommation des antalgiques est moins importante. Donc, c'est une proposition qui est proche. La consommation des antalgiques est moins importante.

Et donc, les patients peuvent ne pas ou ne pas avoir besoin de consommer des antalgiques puisqu'ils n'ont pas de cicatrices, ils n'ont pas de plaies. Je vous rappelle que la plaie sous-costale, elle est très douloureuse. Elle est très douloureuse.

Et donc, c'est un des avantages très avancés de la cellulose par rapport à la chirurgie conventionnelle. Proposition E, se complique rarement d'occlusion par bride. La proposition est vraie, juste.

Donc, avec la celioscopie, on agresse moins avec nos mains les ongles intestinaux et le péritoine qui sont la partie viscérale. Et donc, on a remarqué qu'avec la chirurgie celioscopique, il y a moins de cas d'occlusion sur bride en post-opératoire. Si vous n'avez plus de questions sur la prise en charge de la lithiase vésiculaire par cellulose, pouvez-vous réexpliquer les différentes modalités chirurgicales du cancer du colon selon le segment atteint? Je reprends la question.

Je reprends le traitement chirurgical du cancer du colon. Alors, selon la localisation, effectivement, selon la localisation, l'attitude, elle est différente. Alors, pour le cancer du colon droit, c'est-à-dire le second, le colon ascendant, l'angle colique droit, le geste, c'est toujours une hémicolectomie droite, toujours, j'ai bien dit toujours une hémicolectomie droite avec une anastomose ilio-transverse, terminotermineale, bien sûr avec curage ganglionnaire.

Et sauf que le curage ganglionnaire, il est plus difficile du côté droit parce qu'on doit se méfier de la ligature des vaisseaux, notamment des mésentériques supérieures. L'artère mésentérique supérieure est la même mésentérique supérieure. Donc, le curage ganglionnaire, c'est le fait de ramasser et de squelettiser tous les ganglions qui se trouvent sur le trajet des artères coliques supérieures droites et ilio-séquo-appendiculaires.

Donc, on va tout emporter en monobloc avec la pièce d'une hémicolectomie droite. Et l'hémicolectomie droite ne suppose pas et n'exige pas de préparation colique avant le geste chirurgical. C'est-à-dire que si jamais un jour vous avez un malade qui a un cancer du colon droit, vous pouvez l'opérer dans la foulée immédiatement sans avoir besoin de le préparer et de lui donner un traitement laxatif ou bien un régime sans résidus pour l'opérer.

Pourquoi ? Parce qu'en préopératoire, on peut faire la vidange rétrograde de tout l'intestin grêle. On peut vider l'intestin grêle de son contenu, chose qu'on ne peut pas faire avec le colon gauche.

Donc, si jamais on a une tumeur dont le colon gauche, que ce soit au niveau de l'embryologique gauche, le colon descendant ou bien le colon sigmoïde ou bien le rectum carrément, on ne peut pas faire la préparation du colon droit en préopératoire.

D'où la nécessité, lorsqu'on a un cancer du colon gauche, la nécessité de préparer le malade pour faire un geste en un seul temps. C'est-à-dire faire la résection de la tumeur qui peut être soit une hémicolectomie gauche ou bien une résection segmentaire. À gauche, on peut faire des résections segmentaires, chose qu'on ne peut pas faire à droite.

À droite, c'est toujours une résection, une hémicolectomie droite. Mais à gauche, si par exemple la tumeur siège au niveau de l'embryologique, on peut faire une résection ambulatoire. Et si le malade est préparé, si c'est une chirurgie à froid, on peut faire l'anastomose colocolique sans être obligé d'enlever tout le colon gauche.

De la même manière, si on a une tumeur du sigmoïde, on peut faire une résection segmentaire du sigmoïde, bien sûr avec le curage d'embryonnaire et l'anastomose colorectale supérieure. Bien sûr, en l'absence de tableau d'occlusion. Mais si jamais on a une occlusion, on est obligé dans ce cas de faire une colostomie de Prochamont avant la tumeur et de reprendre le malade une semaine jusqu'à dix jours après, le temps qu'il va prendre un régime sans résidus et de préparer le colon pour pouvoir faire la résection et l'anastomose colorectale.

Je vais rajouter un autre détail concernant les cancers du colon. Quand le malade, bien sûr, il est en péritonite, que ce soit à droite ou à gauche, les sutures ne sont pas permises, on doit terminer le geste par une stomie, que ce soit à droite ou à gauche. Si le malade consulte un stade vraiment tardif, un stade où il y a une péritonite, la tumeur s'est perforée, que ce soit l'accrétion tumorale ou bien diastatique, dans ce cas-là, le geste doit se terminer avec une stomie temporaire, le temps que la péritonite guérisse pour pouvoir reprendre le patient et faire ce qu'on appelle le rétablissement de continuité.

Une autre question, est-ce qu'on pratique la liste du calcul comme ce qu'on fait dans l'ER1 ? Elle est contre-indiquée. La lithotricie et la liste des calculs, la fragmentation par les rayons, elle est contre-indiquée. Pourquoi ? Parce qu'en fragmentant un gros calcul, par exemple de 2 cm, il va s'effriter et il va nous donner une dizaine, une centaine de petits calculs de micro-lithiases, et les micro-lithiases sont plus graves, ils risquent de déclencher, de migrer dans la voie biliaire et de déclencher une pancréasite aiguë qui peut être plus grave que la lithiase vésiculaire.

Je vous rappelle que la pancréasite aiguë, son pronostic, il est imprévisible. Je vous rappelle que dans le cours, on a dit que le pronostic de la pancréasite aiguë, il est imprévisible. D'ailleurs, les Marocains appellent la pancréasite, Pourquoi ? Parce que vous devez expliquer ce détail, et ce détail, il est très important.

Lorsque vous allez prendre en charge des malades, vous devez leur expliquer que le pronostic, il est imprévisible. Alors, je pense que j'ai répondu à toutes les questions, et on va continuer. Le

cancer de l'estomac, il peut être révélé par des douleurs épigastriques, des vomissements alimentaires, des hématoméses, hémorragie digestive basse, constipation.

J'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Le cancer de l'estomac, il peut être révélé, c'est-à-dire qu'il peut se manifester par des douleurs épigastriques, des vomissements alimentaires, des hématoméses, des hémorragies hautes, des hémorragies basses, et de la constipation.

Vos réponses. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? AC. Mademoiselle Ehsan a répondu AC.

Alors, pour la réponse juste, c'est ABCD. Bravo, monsieur Weber, il a répondu juste. Donc, un cancer du colon, de l'estomac, il peut se manifester par des douleurs épigastriques, des épigastalgies, des vomissements alimentaires, des hématoméses et des hémorragies digestives basses.

Est-ce que le cours du cancer de l'estomac est déjà fait? Normalement, c'est pas moi qui va le traiter, c'est monsieur, c'est le professeur Beny, donc, mais je pense qu'il l'a traité, parce qu'il l'a mis sur la plateforme. Vous avez d'autres... Donc, constipation, je pense pas. Une autre question.

Parmi les affections gastriques suivantes, quelles sont celles qui sont considérées comme pré-cancéreuses? La gastrite chronique, le polyp adénomateur, la maladie de Venetiae, la maladie de Viermeyer, la hernie hiatal. Je reprends la question. Parmi les affections gastriques suivantes, quelles sont celles qui sont considérées comme pré-cancéreuses? La gastrite chronique, le polyp adénomateur, la maladie de Venetiae, la maladie de Viermeyer, avec gastrite atrophique, et la hernie hiatal.

Donc, quelqu'un a répondu A, B et D. La réponse juste, c'est A, B, C, D. Donc, les quatre premières propositions. La gastrite chronique, c'est un état pré-cancéreux. Tous les malades qui ont une gastrite chronique doivent être suivis par des fibroscopies pour guetter la cancérisation.

Le cancer de l'osage. Le diagnostic repose sur la fibroscopie osogastro-dodénale avec des biopsies. Position B, il est fréquent chez l'homme.

C, l'intoxication, l'alcool, le tabac est le facteur favorisant le plus important. Monsieur, est-ce que la maladie de Venetiae peut guérir spontanément? Je ne pense pas. C'est une maladie chronique qui nécessite un suivi.

Donc, je pense que si un malade est diagnostiqué, il doit être suivi le long de sa vie, ne serait-ce que pour ce risque de cancérisation qui peut être tardif. Donc, le suivi doit être le restant de la vie. Donc, je reviens aux compositions.

Il est souvent associé à un cancer ORL. Son pronostic est bon. Vos réponses.

J'attends toujours les réponses. Pour le cancer de l'osage, la réponse juste, c'est A, B et C. Le diagnostic repose sur la fibroscopie osogastro-dodénale avec des biopsies. Il est fréquemment

chez l'homme.

C'est vrai. Il est plus fréquent chez l'homme. L'explication, c'est surtout l'alcoolisation et le tabac.

L'association de ces deux éléments. Donc, l'intoxication alcool-tabac, c'est le facteur favorisant le plus important. Une autre question concernant les traumatismes abdominaux.

C'est un motif fréquent de consultations aux urgences chirurgicales. Touche la femme jusqu'à l'homme. Proposition B. Proposition C. Sont le plus souvent isolés.

Peut se manifester par un syndrome hémorragique. Peut se manifester par une péritonite. Une autre question concernant les traumatismes abdominaux.

Les traumatismes abdominaux. Mademoiselle Hajar a répondu ADE. Mademoiselle Selma aussi ADE.

Mademoiselle Menal ADE. Donc, les trois réponses sont justes. ADE.

Effectivement, c'est un motif très fréquent de consultations. C'est un problème de santé publique. Vous savez très bien que les AVP et les accidents de la voie publique sont endémiques au Maroc.

Touche la femme, non. L'homme est plus intéressé que la femme. Cela s'explique par la mobilité.

Ce sont des hommes qui prennent la route plus. Ils sont souvent isolés. Souvent, les traumatismes abdominaux s'intègrent dans le cadre d'un polytraumatisé.

Donc, on a l'association d'un traumatisme traumatologique. On a l'association d'un trauma crânien. Donc, rarement sont les cas où on a un traumatisme abdominal isolé.

Surtout dans le cadre des accidents de la voie publique. Ils peuvent se manifester par un syndrome hémorragique. Pour les deux dernières propositions, c'est vrai.

Vous savez très bien qu'au niveau de l'abdomen, on a des organes qui sont pleins, notamment le foie, la rate, le pancréas. Donc, un traumatisme de ces organes-là va donner une hémorragie interne, un hémopéritoine, voire même un état de choc hémorragique. Donc, ils peuvent se manifester par un syndrome hémorragique.

Ils peuvent se manifester par un tableau de péritonite. C'est le problème des organes creux, notamment l'estomac, le duodénum, l'intestin et le côlon. La perforation de ce segment du tube digestif va entraîner une péritonite.

Vous savez très bien que la prise en charge des traumatismes abdominaux ces dernières années repose sur le traitement conservateur. C'est-à-dire qu'on évite au maximum d'opérer les patients parce qu'on a remarqué qu'un grand nombre de malades opérés qui avaient des

syndromes hémorragiques, lorsqu'on les opère, lorsqu'on fait la laparotomie, à ce moment-là, l'hémostase est déjà faite. Cette attitude, ce sont les chirurgiens infantiles qui l'ont démarrée, surtout avec les traumatismes spléniques parce que les traumatismes spléniques se soldaient dans le temps avant les années 90 par une splénectomie et ces enfants, lorsqu'ils grandissaient, souffraient d'infections à pneumocoque et à méningocoque puisque vous savez très bien que la rate joue un rôle dans l'immunité cellulaire et les patients opérés qui ont subi une splénectomie souffrent en quelque sorte d'un déficit immunitaire et donc les chirurgiens infantiles ont poussé les choses un peu plus loin, ils ont insisté, ils ont développé ce traitement conservateur qui évite d'opérer ces patients qui ont un traumatisme abdominal avec un syndrome hémorragique tant que le malade est stable ou bien a été stabilisé par la transfusion et par la réanimation, on doit éviter au maximum l'intervention chirurgicale.

On n'opère les malades qui ont un traumatisme abdominal avec ces deux exceptions, c'est lorsque on est sûr qu'il y a une péritonite, une perforation d'un organe creux soit par le résultat du scanner qui va montrer un pneumocoque péritoine ou bien lorsque le syndrome hémorragique ne peut pas être jugulé par la réanimation et par la transfusion, ce n'est que chez ces malades-là que l'indication d'exploration et de chirurgie est indiquée. J'attends toujours des questions concernant les traumatismes abdominaux sinon on va passer à d'autres questions. Une autre question elle intéresse l'abcès du foie.

Les bacilles Gram-positifs et les germes Aero-Bi sont les plus fréquemment isolés. Ils peuvent se compliquer d'un choc septique. La localisation la plus fréquente est de l'opère gauche dans deux tiers du cas.

Elles se manifestent par une hépatomégalie douloureuse. Elles se manifestent par une hyperleucocytose lymphocytaire, la prédominance lymphocytaire. Donc la question intéresse l'abcès du foie Première proposition les bâgènes et les germes Aero-Bi sont les plus fréquemment isolés.

Ils peuvent se compliquer d'un choc septique. La localisation la plus fréquente j'attends les réponses. Allo, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Alors mademoiselle, le médecin a répondu pour l'abcès du foie la proposition B est B. La proposition B, oui, ils peuvent se compliquer.

C'est vrai. Ce sont les deux réponses justes. Les germes les plus fréquemment sont les Aero-Bi pas les germes Aero-Bi.

Donc c'est les Aero-Bi. Donc la proposition A est fausse. Ils peuvent se compliquer de chocs septiques, c'est vrai, la localisation la plus fréquente c'est de l'ombre gauche, c'est faux, on a observé, on a remarqué que c'est le foie droit qui est le plus fréquemment touché, et pourquoi, ça s'explique parce que les germes, le mécanisme dans ce moncement du foie, c'est le mécanisme sanguin par les veines portes, et donc les germes lorsqu'ils remontent, ils se localisent à droite, puisque si vous remarquez, et si vous révisez l'anatomie d'une pellicule hépatite, vous allez voir

que la branche droite de la veine porte, elle est verticale, et elle suit le trajet de la veine porte, donc si les germes remontent à travers la veine porte, ils vont se localiser beaucoup plus fréquemment à droite plutôt qu'à gauche.

Se manifeste par une hépatomégalie douloureuse, c'est vrai, donc c'est une hépatomégalie douloureuse et fébrile, donc l'abcès du foie, se manifeste par une hyperleucocytose à prédominance lymphocytaire, c'est faux, on a une prédominance neutrophile, donc la proposition E est fausse. Est-ce que vous avez d'autres questions avant de terminer ce cours ? Est-ce que vous avez d'autres questions concernant toute la pathologie digestive ? Si vous voulez qu'on revienne, ou bien on révise quelques chapitres ? Bien, s'il n'y a pas de questions, je pense que tout le monde est fatigué, je vais terminer ce cours.